

# XAI Project

## Heart Failure Clinical Records

Confronto tra modelli interpretabili basati su regole  
e modelli ensemble non interpretabili

---

### Indice

#### 1. Introduzione del problema e dataset

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 1.1 | Contesto e motivazione         | 2 |
| 1.2 | Il Dataset                     | 3 |
| 1.3 | EDA — Distribuzioni per classe | 4 |
| 1.4 | EDA — Matrice di correlazione  | 5 |

#### 2. Architettura e Implementazione

|     |                                         |    |
|-----|-----------------------------------------|----|
| 2.1 | Struttura del Progetto                  | 6  |
| 2.2 | Pipeline di Elaborazione dei Dati       | 7  |
| 2.3 | Modelli Interpretabili Basati su Regole | 9  |
| 2.4 | Modelli Ensemble Non Interpretabili     | 10 |
| 2.5 | Configurazione e Iperparametri          | 11 |

#### 3. Risultati

|     |                                          |    |
|-----|------------------------------------------|----|
| 3.1 | Metriche Comparative                     | 12 |
| 3.2 | Curve ROC                                | 13 |
| 3.3 | Matrici di Confusione                    | 14 |
| 3.4 | Interpretabilità — Regole RuleFit        | 15 |
| 3.5 | Interpretabilità — Feature Importance RF | 16 |
| 3.6 | Cross-Validation 10-fold                 | 17 |

## Contesto e motivazione

---

### Il problema

L'insufficienza cardiaca è una condizione clinica grave in cui il cuore non riesce a pompare sangue in modo sufficiente. Identificare i fattori di rischio associati al decesso è fondamentale per supportare le decisioni cliniche e migliorare la prognosi dei pazienti.

### Obiettivo

Il progetto confronta due famiglie di modelli di machine learning per la predizione della mortalità: modelli interpretabili basati su regole (rule-based) e modelli non interpretabili basati su ensemble di alberi. L'obiettivo è valutare il trade-off tra performance predittiva e interpretabilità in un contesto clinico ad alta criticità.

### Explainable AI in ambito clinico

In medicina, un modello non spiegabile — per quanto accurato — non è direttamente utilizzabile come strumento di supporto decisionale: il medico deve poter comprendere e validare le motivazioni di ogni predizione. I modelli intrinsecamente interpretabili soddisfano questo requisito senza richiedere metodi post-hoc aggiuntivi (es. SHAP, LIME), che possono introdurre approssimazioni e spiegazioni fuorvianti.

### Struttura del report

Il Capitolo 1 introduce il problema clinico, descrive il dataset e presenta l'analisi esplorativa. Il Capitolo 2 illustra l'architettura del progetto, la pipeline di elaborazione dei dati, i modelli utilizzati e la loro configurazione. Il Capitolo 3 presenta i risultati e il confronto delle performance. Il Capitolo 4 raccoglie le conclusioni, l'analisi clinica dei risultati e i limiti del lavoro.

## Il Dataset

### Descrizione

Il dataset Heart Failure Clinical Records (UCI, id=519) raccoglie cartelle cliniche di 299 pazienti con insufficienza cardiaca seguiti in follow-up. La variabile target DEATH\_EVENT indica se il paziente è deceduto durante il periodo di osservazione.

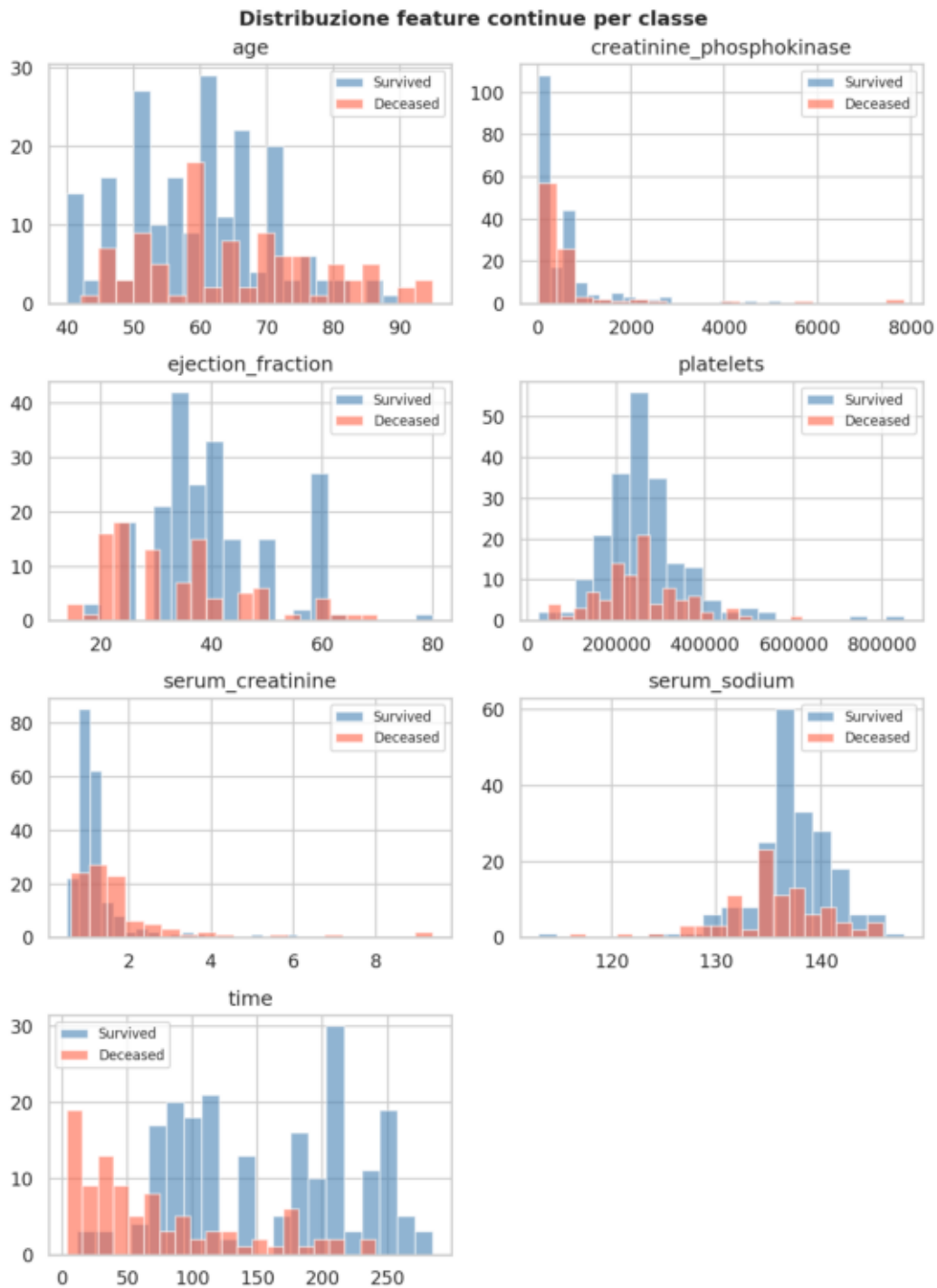
Campioni: 299 | Feature: 12 | Decessi: 96 (32.1%) | Sopravvissuti: 203 (67.9%)

### Gestione delle feature: binarie vs continue

Le 12 feature si dividono in 5 binarie (anaemia, diabetes, high\_blood\_pressure, sex, smoking — valori 0/1) e 7 continue (age, creatinine\_phosphokinase, ejection\_fraction, platelets, serum\_creatinine, serum\_sodium, time). I modelli ensemble e la maggior parte dei rule-based le ricevono direttamente. RuleFit richiede standardizzazione (StandardScaler), mentre BayesianRuleList richiede feature esclusivamente binarie: le variabili continue vengono quindi discretizzate in bin tramite KBinsDiscretizer con one-hot encoding prima del fitting.

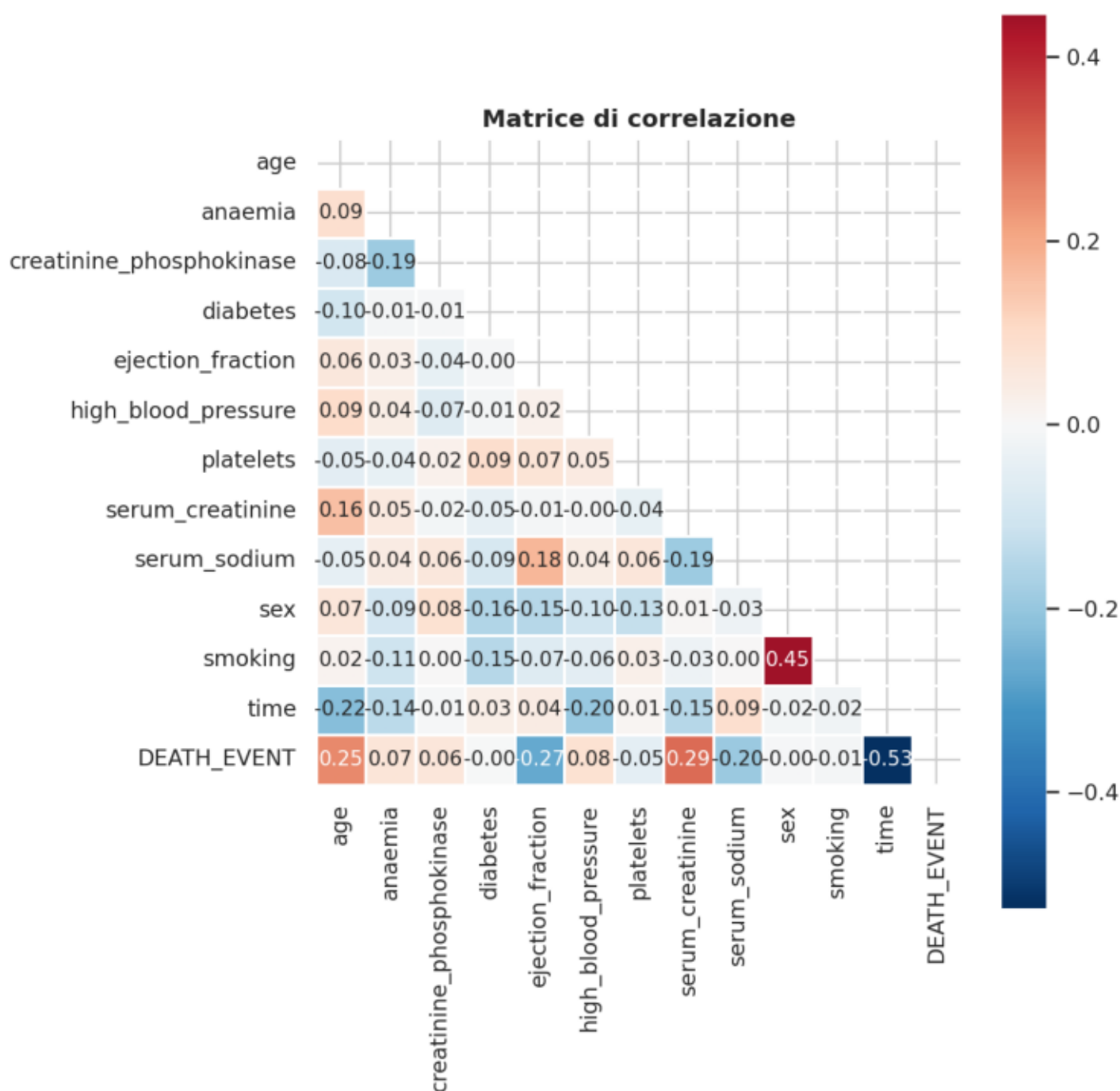
| Feature                  | Tipo     | Descrizione                                               |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| age                      | continua | Età del paziente (anni)                                   |
| anaemia                  | binaria  | Presenza di anemia (0/1)                                  |
| creatinine_phosphokinase | continua | Livello CPK nel sangue (mcg/L)                            |
| diabetes                 | binaria  | Presenza di diabete (0/1)                                 |
| ejection_fraction        | continua | Percentuale di sangue pompata dal ventricolo sinistro (%) |
| high_blood_pressure      | binaria  | Presenza di ipertensione (0/1)                            |
| platelets                | continua | Conta piastrinica (kiloplatelets/mL)                      |
| serum_creatinine         | continua | Livello di creatinina serica (mg/dL)                      |
| serum_sodium             | continua | Livello di sodio sierico (mEq/L)                          |
| sex                      | binaria  | Sesso biologico (0=F, 1=M)                                |
| smoking                  | binaria  | Fumatore (0/1)                                            |
| time                     | continua | Durata del follow-up (giorni)                             |

## EDA — Distribuzioni per classe



Ogni istogramma sovrappone la distribuzione di una feature per sopravvissuti (blu) e deceduti (rosso): più le due curve sono separate, maggiore è il potere predittivo di quella variabile. `time` è il discriminatore più potente — un follow-up breve corrisponde quasi sempre a decesso, segno di rapido deterioramento clinico. `serum_creatinine` alta indica compromissione renale, spesso associata a esiti peggiori; `ejection_fraction` bassa segnala che il ventricolo sinistro pompa una quota insufficiente di sangue. `platelets` e `creatinine_phosphokinase` mostrano distribuzioni largamente sovrapposte: contributo predittivo individuale marginale.

## EDA — Matrice di correlazione



Ogni cella mostra la correlazione di Pearson tra due variabili: vale +1 se quando una sale anche l'altra sale sempre, -1 se quando una sale l'altra scende sempre, 0 se non c'è alcuna relazione lineare tra le due. Valori vicini a  $\pm 0.5$  o oltre indicano una relazione abbastanza chiara; vicini a 0 indicano variabili sostanzialmente indipendenti. time ha la correlazione più forte con DEATH\_EVENT (-0.53): pazienti con follow-up lungo tendono a sopravvivere. serum\_creatinine (+0.29) ed ejection\_fraction (-0.27) sono i segnali biochimici più informativi. Le feature binarie mostrano correlazioni deboli, sotto  $\pm 0.15$ .

## Struttura del Progetto

### Organizzazione del codice

Il progetto è organizzato in una cartella `src/` con sei moduli distinti, ciascuno con una responsabilità precisa. Questa separazione permette di modificare una componente senza toccare le altre e rende il codice più leggibile e testabile.

| Modulo                      | Responsabilità                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>config.py</code>      | Centralizza iperparametri, path e costanti — unico punto di modifica       |
| <code>data_loader.py</code> | Download UCI, cache CSV, split stratificato, tre varianti di preprocessing |
| <code>models.py</code>      | Factory function per ciascuno degli 8 modelli — nessuna logica di training |
| <code>evaluate.py</code>    | Calcolo metriche, generazione di tutti i grafici, cross-validation         |
| <code>main.py</code>        | Orchestrazione dell'intera pipeline end-to-end, in ordine fisso            |
| <code>report.py</code>      | Lettura degli artefatti salvati e generazione del PDF report               |

### Output della pipeline

Ogni esecuzione di `main.py` produce artefatti salvati su disco: i dati grezzi vengono cachati in `data/` (`X.csv`, `y.csv`) per evitare di riscargarli ogni volta. Le metriche vengono salvate in `results/metrics_summary.csv`. I grafici vengono salvati in `results/plots/` come PNG ad alta risoluzione (150 DPI). Il report finale viene scritto in `results/report.pdf`. Questa separazione tra esecuzione e report permette di rigenerare il PDF senza rieseguire l'intera pipeline.

### Dipendenze principali

`scikit-learn` gestisce preprocessing, metriche e cross-validation. `imodels` fornisce le implementazioni dei modelli rule-based (`RuleFit`, `GreedyRuleList`, `BayesianRuleList`, `FIGS`, `SkopeRules`). `xgboost` implementa XGBoost. `ucimlrepo` scarica il dataset direttamente dal repository UCI. `matplotlib` e `seaborn` gestiscono la generazione di tutti i grafici e del report PDF.

## Pipeline di Elaborazione dei Dati

---

### Split stratificato

Il dataset viene diviso in training (80%, 239 campioni) e test (20%, 60 campioni) con `train_test_split(stratify=y)`: la stratificazione garantisce che entrambe le parti mantengano la stessa proporzione di deceduti (~32%) presente nel dataset originale. Senza stratificazione, con un dataset così piccolo, uno split casuale potrebbe produrre un test set con proporzioni molto diverse, rendendo le metriche poco affidabili. Il seed fisso (`RANDOM_STATE=42`) garantisce la riproducibilità.

### Tre varianti di preprocessing

I modelli richiedono rappresentazioni diverse delle stesse feature, quindi il preprocessing produce tre versioni del training e test set in parallelo. La versione raw è il DataFrame originale con le 12 feature così come sono: usata da `GreedyRuleList`, `FIGS`, `SkopeRules` e dai modelli ensemble (come array NumPy). La versione scalata applica `StandardScaler`, che porta ogni feature continua a media 0 e varianza 1: necessaria per `RuleFit`, che usa la regressione Lasso internamente e quindi è sensibile alla scala delle variabili. La versione discretizzata usa `KBinsDiscretizer(n_bins=4, encode='onehot-dense', strategy='quantile')`: ogni feature continua viene suddivisa in 4 intervalli di uguale frequenza, ciascuno codificato come colonna binaria. Il risultato è un array di 48 colonne binarie (12 feature x 4 bin), obbligatorio per `BayesianRuleList` che per design accetta solo valori strettamente 0/1.

## Pipeline di Elaborazione dei Dati (continua)

---

### PreparedData — struttura dati condivisa

Il risultato del preprocessing è incapsulato in un dataclass `PreparedData` che raccoglie tutte le versioni in un unico oggetto: `X_train/X_test (raw)`, `X_train_scaled/X_test_scaled`, `X_train_disc/X_test_disc`, `y_train/y_test`, la lista dei nomi delle feature e `scale_pos_weight` per XGBoost. `main.py` accede ai campi tramite `data.X_train_scaled`, `data.y_test` ecc., senza dover gestire decine di variabili separate. Lo scaler e il discretizzatore sono fittati solo sul training set e applicati al test set con `transform()`, evitando data leakage.

### Sbilanciamento delle classi

Il dataset contiene 203 sopravvissuti e 96 deceduti (~32% positivi). Questo sbilanciamento è gestito in modo diverso per ciascun modello: Random Forest usa `class_weight='balanced'` che pesa ogni campione inversamente alla frequenza della sua classe. XGBoost usa `scale_pos_weight` calcolato automaticamente come rapporto tra negativi e positivi nel training set. Gli altri modelli non hanno meccanismi nativi e trattano le classi con peso uguale.



## Modelli Interpretabili Basati su Regole

---

I modelli basati su regole producono predizioni nella forma di liste di condizioni if-then direttamente leggibili. Ogni regola può essere validata da un esperto di dominio senza strumenti aggiuntivi.

### **RuleFit**

Estrae regole da un ensemble di alberi, poi allena una regressione lineare penalizzata (Lasso) sui valori delle regole. Il coefficiente di ogni regola indica il suo peso nella predizione finale.

Richiede feature standardizzate.

### **GreedyRuleList**

Costruisce una lista ordinata di regole if-then in modo greedy, massimizzando ad ogni passo la riduzione dell'impurità. La lista si legge dall'alto verso il basso: si applica la prima regola che si attiva sul campione.

### **BayesianRuleList (BRL)**

Apprende una lista di regole tramite inferenza Bayesiana (MCMC). Richiede feature binarie: le variabili continue vengono discretizzate in bin (one-hot encoding) prima del fitting. Produce liste compatte e altamente leggibili.

### **FIGS — Fast Interpretable Greedy-Tree Sums**

Il modello è una somma di piccoli alberi decisionali, ciascuno appreso in modo greedy sui residui del passo precedente. Combina interpretabilità strutturale con una capacità espressiva maggiore rispetto a un singolo albero.

### **SkopeRules**

Genera regole ad alta precisione e recall tramite sub-campionamenti ripetuti di ensemble di alberi, poi de-duplica le regole simili. Ogni regola è corredata da statistiche di precisione, recall e support sul training set.

## Modelli Ensemble Non Interpretabili

---

I modelli ensemble combinano centinaia di alberi decisionali per ottenere performance superiori, ma il processo decisionale risulta opaco (black box). Sono usati come baseline di riferimento per valutare il gap di performance rispetto ai modelli interpretabili.

### Random Forest

Allena N alberi decisionali su sotto-campioni casuali del dataset (bagging) e su sottoinsiemi casuali delle feature (feature bagging). La predizione finale è la media delle probabilità dei singoli alberi. Riduce la varianza rispetto al singolo albero. Configurato con `class_weight='balanced'` per gestire lo sbilanciamento.

### Gradient Boosting (sklearn)

Allena alberi sequenzialmente: ogni albero corregge gli errori del precedente minimizzando il gradiente della loss (boosting). Riduce il bias rispetto al bagging. Parametri: 200 stimatori, learning rate 0.05, profondità massima 4, subsample 0.8.

### XGBoost

Implementazione ottimizzata del gradient boosting con regolarizzazione L1/L2, gestione nativa dei valori mancanti e parallelismo. Parametro `scale_pos_weight` impostato automaticamente per bilanciare le classi in base alla distribuzione del training set.

## Configurazione e Iperparametri

Tutti i parametri del progetto sono centralizzati in `config.py`, importato da ogni modulo. Questo garantisce che una singola modifica si propaghi all'intera pipeline senza rischio di disallineamenti. Di seguito la motivazione di ogni scelta.

### Parametri generali

| Parametro       | Valore | Motivazione                                                  |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| RANDOM_STATE    | 42     | Seed fisso per riproducibilità di split e modelli stocastici |
| TEST_SIZE       | 0.2    | 20% test (60 campioni); bilancia valutazione e training      |
| CV_FOLDS        | 10     | 10-fold CV: stima robusta su dataset piccoli                 |
| BINARY_FEATURES | (5)    | Feature binarie escluse da StandardScaler                    |

### Modelli rule-based

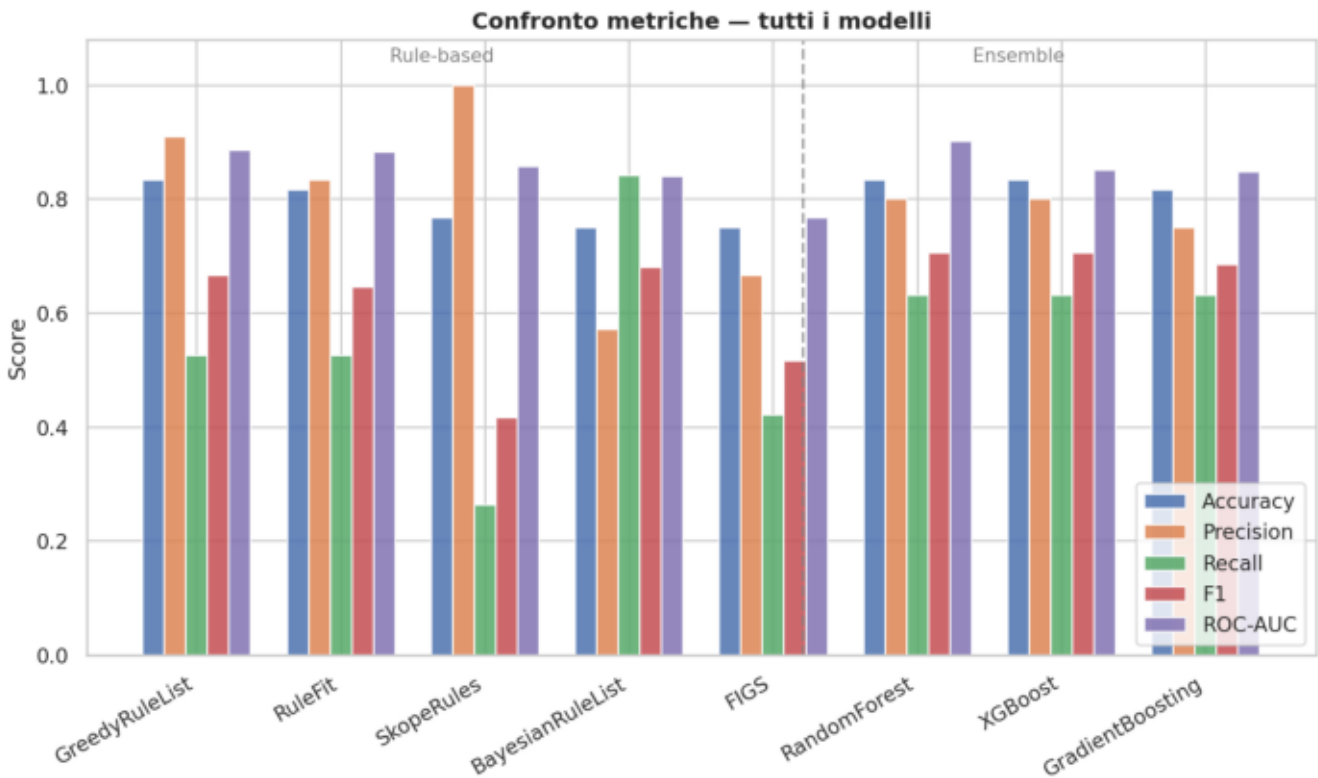
| Parametro           | Valore | Motivazione                                                |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| RULEFIT_MAX_RULES   | 30     | Limita le regole candidate; troppe degenerano in black-box |
| GRL_MAX_DEPTH       | 6      | Profondità massima della lista greedy (default libreria)   |
| BRL_MAX_ITER        | 20 000 | Iterazioni MCMC sufficienti per la convergenza             |
| BRL_MAX_CARDINALITY | 2      | Max 2 condizioni per regola: mantiene leggibilità          |
| FIGS_MAX_RULES      | 10     | Alberi nella somma FIGS; oltre 10 perde interpretabilità   |
| SKOPE_N_ESTIMATORS  | 100    | Pool ampio di alberi base per diversità delle regole       |
| SKOPE_PRECISION_MIN | 0.5    | Soglia minima di precisione per accettare una regola       |
| SKOPE_RECALL_MIN    | 0.4    | Copertura minima dei positivi nel training per regola      |

### Modelli ensemble

| Parametro         | Valore | Motivazione                                                   |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| RF_N_ESTIMATORS   | 200    | Abbastanza alberi da stabilizzare le stime RF                 |
| GB_N_ESTIMATORS   | 200    | Iterazioni di boosting sufficienti senza overfitting          |
| GB_LEARNING_RATE  | 0.05   | Passi piccoli nel gradiente: riduce il rischio di overfitting |
| GB_MAX_DEPTH      | 4      | Alberi profondi limitati; il boosting compensa il bias        |
| XGB_N_ESTIMATORS  | 200    | Allineato a GB per confronto diretto                          |
| XGB_LEARNING_RATE | 0.05   | Come GB; XGBoost aggiunge anche regolarizzazione L1/L2        |
| XGB_MAX_DEPTH     | 4      | Come GB: limita i learner deboli nel boosting sequenziale     |

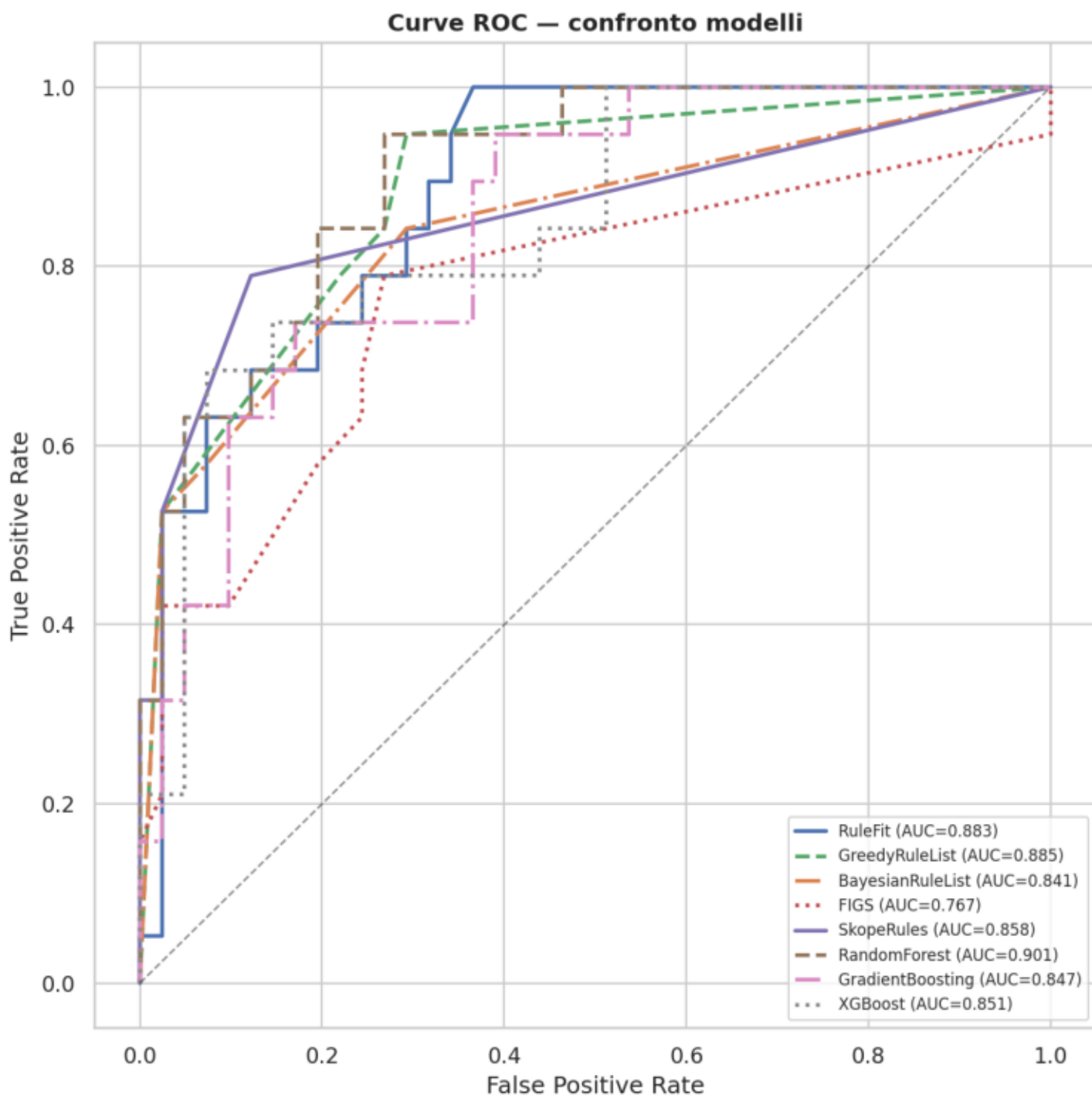
## Metriche Comparative

| Modello          | Type       | Accuracy | Precision | Recall | F1     | ROC-AUC |
|------------------|------------|----------|-----------|--------|--------|---------|
| RandomForest     | Ensemble   | 0.8333   | 0.8       | 0.6316 | 0.7059 | 0.9012  |
| GreedyRuleList   | Rule-based | 0.8333   | 0.9091    | 0.5263 | 0.6667 | 0.8851  |
| RuleFit          | Rule-based | 0.8167   | 0.8333    | 0.5263 | 0.6452 | 0.8825  |
| SkopeRules       | Rule-based | 0.7667   | 1.0       | 0.2632 | 0.4167 | 0.8575  |
| XGBoost          | Ensemble   | 0.8333   | 0.8       | 0.6316 | 0.7059 | 0.8511  |
| GradientBoosting | Ensemble   | 0.8167   | 0.75      | 0.6316 | 0.6857 | 0.8472  |
| BayesianRuleList | Rule-based | 0.75     | 0.5714    | 0.8421 | 0.6809 | 0.8408  |
| FIGS             | Rule-based | 0.75     | 0.6667    | 0.4211 | 0.5161 | 0.767   |



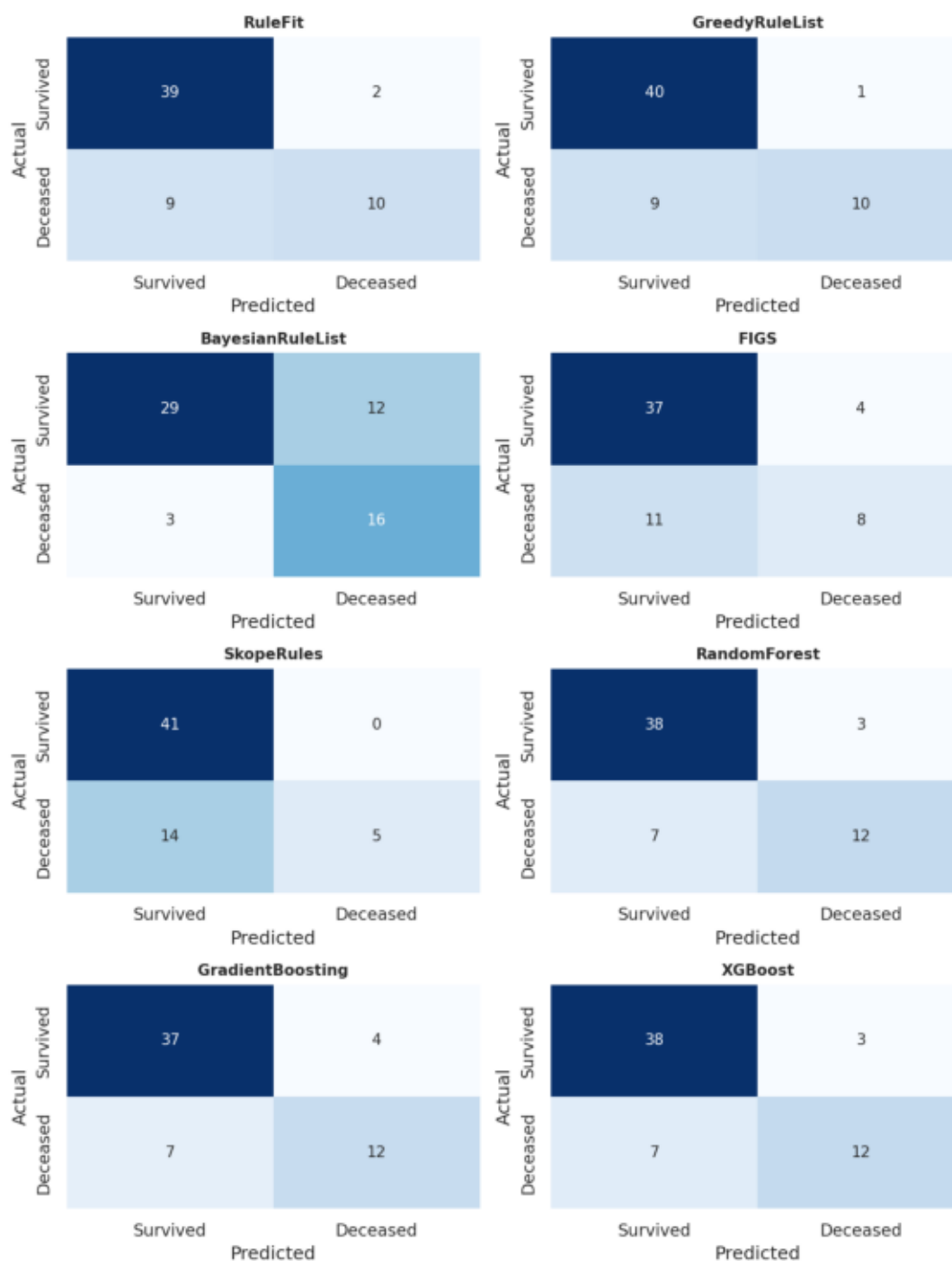
Ogni gruppo di barre rappresenta un modello; i cinque colori corrispondono alle cinque metriche. Accuracy e F1 riassumono la qualità complessiva, ma su classi sbilanciate possono essere fuorvianti. Precision misura quante predizioni 'deceduto' sono corrette; Recall quante morti reali vengono identificate — in clinica un Recall basso (morte non rilevata) è più pericoloso di una Precision bassa (falso allarme). ROC-AUC è la metrica più robusta: misura la capacità di separare le classi indipendentemente dalla soglia. GreedyRuleList è il miglior rule-based per F1 e Accuracy. SkopeRules ottiene ROC-AUC 0.858 con Precision=1.0 e Recall=0.263: identifica pochi deceduti ma senza mai

## Curve ROC



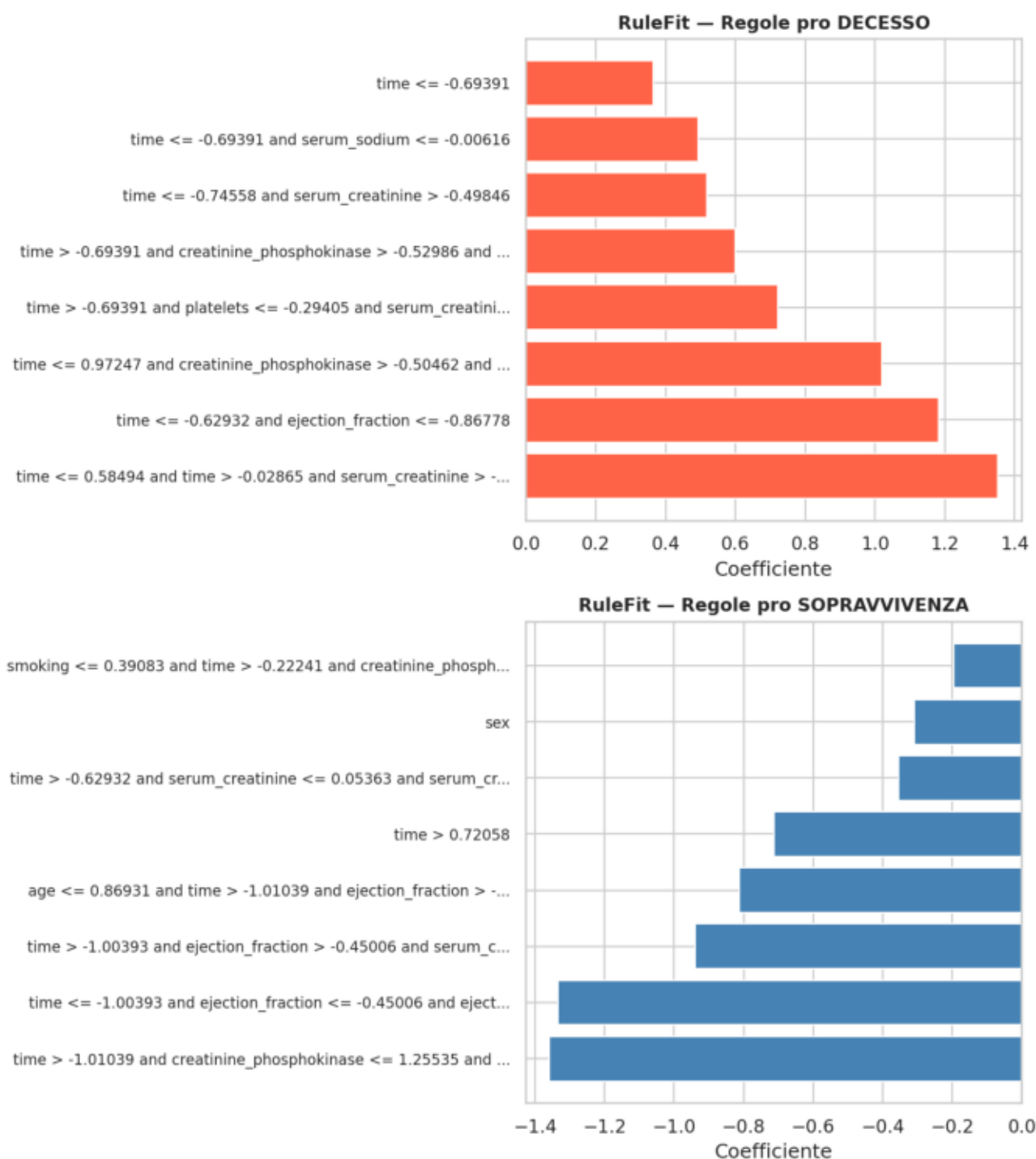
La curva ROC traccia il True Positive Rate (Recall, asse y) contro il False Positive Rate (1 - Specificità, asse x) al variare della soglia di classificazione. Un modello perfetto punta all'angolo in alto a sinistra (TPR=1, FPR=0); uno casuale segue la diagonale tratteggiata (AUC=0.50). L'area sotto la curva (AUC) riassume la performance in un unico numero indipendente dalla soglia: valori sopra 0.80 sono considerati buoni in ambito clinico. Random Forest raggiunge AUC 0.901, il più alto. SkopeRules e GreedyRuleList seguono (~0.89), risultato notevole per modelli intrinsecamente interpretabili. FIGS è il più debole (~0.77), penalizzato dalla struttura rigida.

## Matrici di Confusione



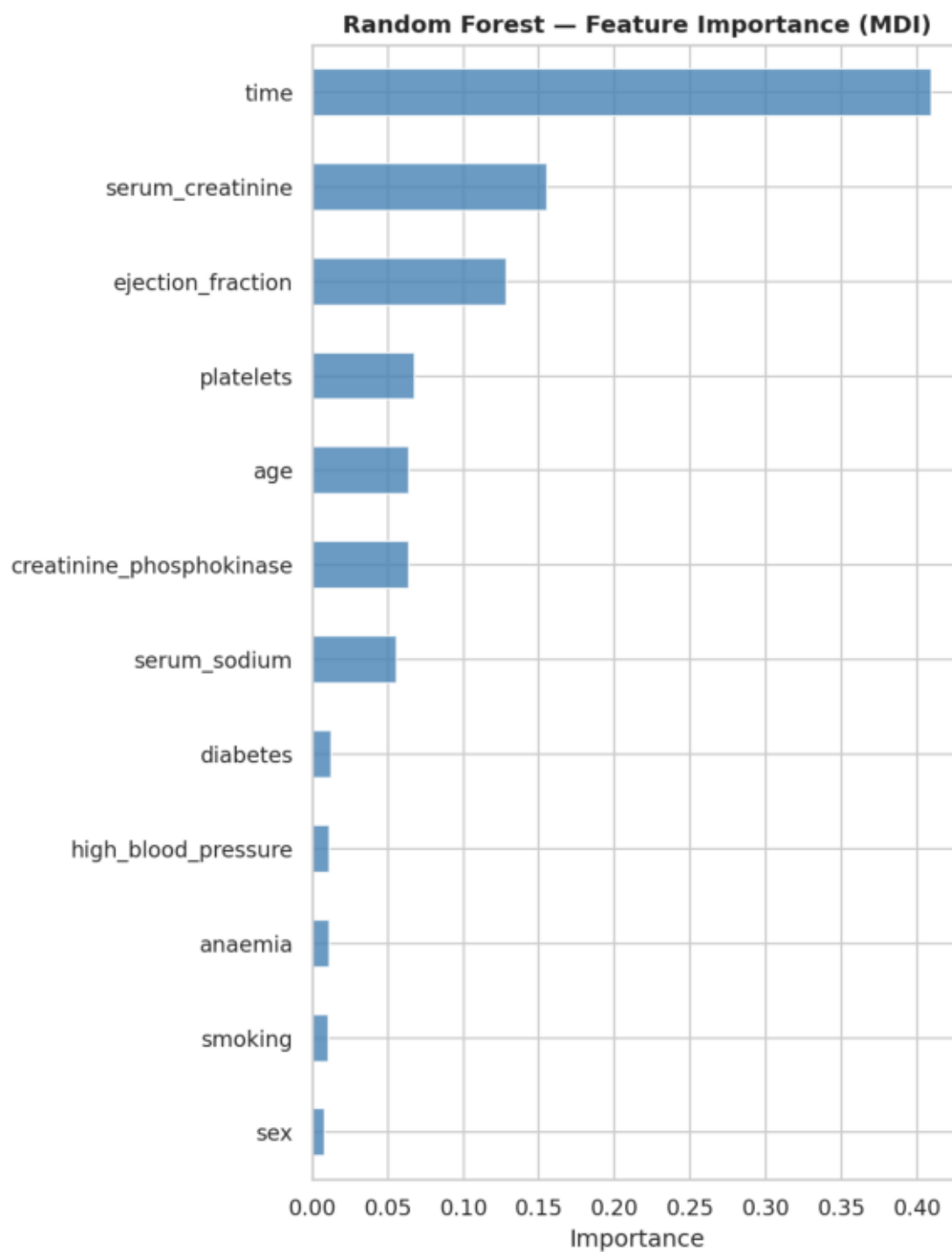
Ogni cella indica: riga = classe reale, colonna = classe predetta. La diagonale principale (celle più scure) raccoglie le predizioni corrette; gli elementi fuori diagonale sono gli errori. In clinica i due tipi di errore hanno costo asimmetrico: un falso negativo (morte non rilevata) è più grave di un falso positivo (falso allarme). BayesianRuleList massimizza il Recall sui deceduti — pochi falsi negativi — a scapito di più falsi positivi. Gli ensemble (RandomForest, XGBoost) bilanciano meglio i due errori. SkopeRules ha Precision=1.0 ma Recall=0.263: identifica solo 5 deceduti su 19, senza mai produrre falsi positivi — comportamento by design delle sue soglie di accettazione.

## Interpretabilità — Regole RuleFit



RuleFit assegna a ogni regola estratta un coefficiente tramite regressione Lasso: coefficiente positivo (barre rosse, grafico superiore) significa che quella condizione aumenta la probabilità di decesso; negativo (blu, inferiore) la diminuisce. Le regole più influenti nel predire il decesso coinvolgono time basso e serum\_creatinine alta, confermando i pattern dell'EDA. Le regole pro-sopravvivenza implicano ejection\_fraction più alta e follow-up lungo. La penalizzazione Lasso azzerava i coefficienti delle regole ridondanti, mantenendo solo quelle con effetto reale sulla predizione.

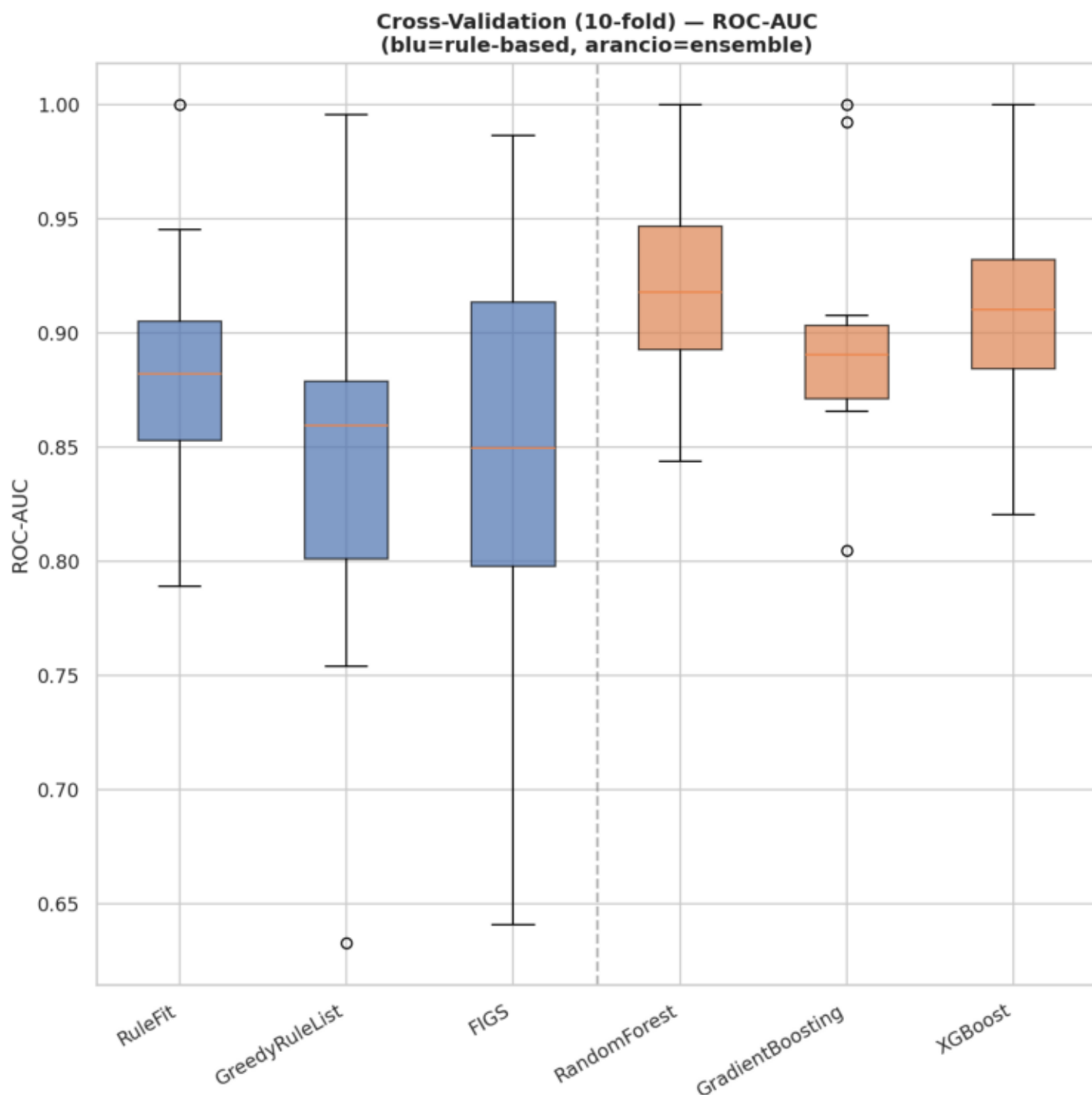
## Interpretabilità — Feature Importance RF



L'importanza MDI (Mean Decrease in Impurity) misura di quanto ogni feature riduce l'impurità media nei nodi degli alberi del Random Forest: valori più alti indicano feature più utilizzate e discriminative. `time` domina nettamente, seguita da `serum_creatinine` ed `ejection_fraction` — le stesse tre variabili che emergono dalle regole di `RuleFit` e `GreedyRuleList`: una validazione incrociata tra approcci molto diversi. Le feature binarie (`anaemia`, `diabetes`, `sex`, `smoking`) hanno importanza marginale, coerente con le basse correlazioni dell'EDA.



## Cross-Validation 10-fold



Il boxplot mostra la distribuzione del ROC-AUC su 10 fold stratificati: mediana, IQR (bordi del box) e range (baffi). La stratificazione garantisce che ogni fold mantenga la stessa proporzione di deceduti (~32%) del dataset completo, rendendo la stima più affidabile. Random Forest ha la mediana più alta e IQR contenuto: performance stabile e consistente tra i fold. RuleFit è il miglior rule-based in CV. FIGS mostra alta varianza — instabile su dataset piccoli. GreedyRuleList ottiene  $0.843 \pm 0.096$  tramite un custom scorer che aggira un'incompatibilità con l'API sklearn.

## Conclusioni

### Confronto tra approcci

I modelli ensemble raggiungono ROC-AUC superiore (Random Forest 0.901, XGBoost 0.851) ma il divario con i rule-based non è netto: GreedyRuleList (0.885) e RuleFit (0.883) li superano entrambi. Su soli 299 campioni la semplicità strutturale dei modelli a regole riduce il rischio di overfitting, risultando competitiva. GreedyRuleList offre il miglior F1 rule-based (0.667) con una lista ordinata di condizioni leggibile da un clinico. RuleFit assegna coefficienti espliciti a ogni regola, rendendo visibile il peso relativo di ciascuna. BayesianRuleList privilegia il recall (0.842): sovrastima i decessi, il che in medicina è spesso preferibile a sottostimarli. FIGS ha AUC più basso (0.767) ma struttura additiva particolarmente trasparente. SkopeRules raggiunge Precision=1.0 con Recall=0.263: non produce mai falsi positivi, ma identifica solo 5 deceduti su 19 — utile quando ogni allarme deve corrispondere a un caso realmente critico.

### Precision vs Recall in ambito clinico

Il trade-off tra precisione e recall non è neutro in contesti medici. Alta recall minimizza i falsi negativi (morti non rilevate), che in clinica sono più pericolosi dei falsi positivi (falsi allarmi). Alta precisione garantisce invece che ogni segnalazione sia affidabile, preferibile quando si pianificano interventi invasivi. La scelta del modello dipende quindi dal contesto d'uso, e la trasparenza dei modelli rule-based è la condizione necessaria per fare questa scelta in modo consapevole.

### Migliori modelli per categoria:

| Categoria  | Modello        | ROC-AUC | F1     |
|------------|----------------|---------|--------|
| Rule-based | GreedyRuleList | 0.8851  | 0.6667 |
| Ensemble   | RandomForest   | 0.9012  | 0.7059 |

## Conclusioni (continua)

---

### Validazione qualitativa delle regole

Le feature più ricorrenti — time (follow-up), serum\_creatinine ed ejection\_fraction — sono coerenti con la letteratura clinica sull'insufficienza cardiaca: follow-up breve segnala una fase acuta critica, creatinina alta indica insufficienza renale spesso letale in questo contesto, ejection\_fraction bassa riflette ridotta capacità di pompa. Il fatto che i modelli apprendano autonomamente queste relazioni costituisce una validazione qualitativa: catturano pattern fisiopatologici reali, non solo correlazioni statistiche.

### Stabilità in cross-validation

Random Forest ( $0.918 \pm 0.044$ ) e XGBoost ( $0.910 \pm 0.049$ ) sono i modelli più stabili. RuleFit raggiunge  $0.884 \pm 0.058$  — il miglior risultato tra i rule-based in CV e competitivo con gli ensemble. GreedyRuleList ottiene  $0.843 \pm 0.096$ , con varianza più alta ma attesa su fold di circa 24 campioni. FIGS ha la varianza maggiore ( $0.847 \pm 0.110$ ), indice di instabilità strutturale su dataset piccoli.

### Limiti e sviluppi futuri

Con 60 campioni nel test set (19 deceduti) ogni metrica è soggetta ad alta varianza: un solo paziente classificato diversamente sposta F1 di oltre 0.05. I risultati sono quindi indicativi e richiedono validazione su coorti esterne prima di qualsiasi applicazione clinica. Ulteriori sviluppi potrebbero includere la calibrazione delle probabilità predette e l'integrazione in un sistema di supporto decisionale con supervisione medica — contesto in cui la trasparenza dei modelli rule-based resta il requisito imprescindibile.